



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:18

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 33150739 - ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

Fecha de Nacimiento: 10/12/1948

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO BOSTON CALLE DEL LAGO CRA 46

Teléfono: 3203820086

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante:

Teléfono Acomp.:

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: SAID CLARETE DE LA ROSA

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Fecha de Atención: 26/01/2020 08:59

Admisión: AD568224

Edad: 71 año(s), 1 mes(es) 16 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.:

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: Pinvestigacion

Sexo: F

Estado Civil: Casado

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 02/01/2020 08:40

Cama: 4--16

Motivo de la Consulta:

" ESTOY CON FIEBRE HACE UN MES"

ANTECEDENTES:

- PERSONALES:

* 1-> NIEGA

* 2-> NIEGA

* 5-> NIEGA

* 6-> NIEGA

- FAMILIARES:

NIEGA

- ALÉRGICOS:

- QUIRÚRGICOS:

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 1 MES DE EVOLUCION CONSISTENTE EN FIEBRE NO CUANTIFICADA ASOCIADO A TOS SECA EMETIZANTE MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA, REFIERE DEPOSICIONES LIQUIDAS SIN MOCO SIN SSNAGRE #15 EL DIA DE AYER

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, CON PARACLINICOS DENTRO DE LIMITES EXCEPTUANDO FUNCIÓN RENAL QUE ESTA ALTERADA, SIGNOS VITALES EN METAS, PACIENTE QUIEN A CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE TIEMPO PROTOCOLARIO DE TERAPIA RIPE INTRAHOSPITALARIO HOY 15 DÍAS CON ADECUADA TOLERANCIA, POR LO QUE EL DÍA DE HOY SE DECIDE DAR ALTA MEDICA CON TERAPIA AMBULATORIA, CITA CONTROL, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS QUE PUEDEN SER RECLAMADOS DE MANERA EXTERNA PARA POSTERIOR REEVALUACION AMBULATORIA, ADEMÁS SE LE DA ALTA CON CITA CON NEFROLOGIA POR LA PERSISTENCIA DE AZOADOS ELEVADOS Y SE LE SOLICITAN BUN, CREATININA PARA LLEVAR A CITA CON NEFROLOGIA. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Revisión Por Sistema:

REFIERE TOS, FIEBRE, DEPOSICIONES LIQUIDAS, DOLOR ABDOMINAL, VOMITOS, CEFALEA, NIEGA: DISNEA, DOLOR TORACICO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA Y ROSADA, CUELLO MÓVIL, SIN ADENOPATIAS, SIN MASAS, SIN INGURGITACION YUGULAR, SIN RIGIDEZ DE NUCA

Tórax:

SIMÉTRICO EXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, CREPITOS EN CAMPOS IZQUIERDOS, NI SIBILANTES, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

Abdomen:

PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, NO MASAS, NO MEGALIAS, PUÑO PERCUSION NEGATIVA

Piel y faneras:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

LEVE PALIDEZ MUCOCUTANEA

Genito-Urinario:

NO EXPLORADO

Extremidades:

SIMÉTRICAS SIN EDEMA, PULSOS PALPABLES, FUERZA MUSCULAR 5/5 EN 4 EXTREMIDADES, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS PRESENTES, CAMINA POR SUS PROPIOS MEDIOS, LLENADO CAPILAR < 2 SEG

Sistema nervioso central:

CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADO EN SUS 3 ESFERAS, MARCHA SIN ALTERACIONES, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN NEUROLÓGICA, SIN DÉFICIT APARENTE MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE 1 MES DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN FIEBRE NO CUANTIFICADA ASOCIADO A TOS SECA EMETIZANTE MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA, REFIERE DEPOSICIONES LIQUIDAS SIN MOCO SIN SSSNAGRE #15 EL DÍA DE AYER, ACTUALMENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, TAQUICÁRDICA, RESTO DE SIGNOS VITALES DENTRO DE LÍMITES NORMALES, CREPITOS EN CAMPOS PULMONARES IZQUIERDO, SAPO₂:97%, LEVE PALIDEZ MUCOCUTANEA, PACIENTE CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, SE INGRESA PARA MANEJO

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal:

J159 : NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1:

R509 : FIEBRE, NO ESPECIFICADA

EVOLUCIONES:

Fecha: 02/01/2020: 15:30:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MELKIS ANTONIO BUEL VAS VILLALBA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 2. GASTROENTERITIS DE PROBABLE ORIGEN INFECCIOSO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ASTENIA, ADINAMIA, NIEGA DEPOSICIONES DIARREICAS ACTUALMENTE.

Objetivo:

FC: 86 FR: 18 TA: 110/60 SATO₂: 88%

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL SEMSECA, CUELLO MÓVIL SIN MASAS ADENOMEGALIAS, MECÁNICA VENTILATORIA SIN ALTERACIONES, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN HEMTORAX DERECHO, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESNETE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, LOS PULSOS PERIFÉRICOS ESTÁN PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA OCTAVA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE CONSULTA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS DE PROBABLE ORIGEN INFECCIOSO. ADEMÁS, PACIENTE REFIERE PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS + TOS HACE UN MES. ACTUALMENTE, PACIENTE CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, SE AUSCULTAN CRÉPITOS EN BASE PULMONAR IZQUIERDA, PALIDEZ MUCOCUTÁNEA PARACLÍNICOS SIN LEUCOCITOSIS O ALTERACIÓN DE LÍNEAS CELULARES. FUNCIÓN RENAL LEVEMENTE ALTERADA QUE PODRÍA DEBERSE A LA DESHIDRATACIÓN DEL PACIENTE. RX DE TÓRAX QUE REPORTE ENFERMEDAD INTERSTICIAL DIFUSA Y ATEROMATOSIS. SE ORDENA HOSPITALIZACIÓN, PARACLÍNICOS DE CONTROL, VIH, COPROLÓGICO Y COPROSCÓPICO PARA DETERMINAR FOCO DE INFECCIÓN.

Fecha: 03/01/2020: 09:57:44, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOHN ALEXANDER ANGULO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 3. NEUMONÍA MULTILOBAR

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE MEJORÍA, NIEGA DEPOSICIONES LIQUIDAS CON MOCO O SANGRE, NIEGA TOS, NIEGA FIEBRE.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL SEMSECA, CUELLO MÓVIL SIN MASAS ADENOMEGALIAS, MECÁNICA VENTILATORIA SIN ALTERACIONES, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN HEMTORAX DERECHO, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, LOS PULSOS PERIFÉRICOS ESTÁN PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA OCTAVA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS INFECCIOSA, SIN EMBARGO YA SE ENCUENTRA RESUELTA POR SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE PROCESO RESPIRATORIO, SE ORDENÓ TAC DE TÓRAX QUE MUESTRA INFILTRADOS ALVEOLARES MULTILOBULAR IZQUIERDO (LÓBULO SUPERIOR Y LÓBULO INFERIOR), A LA ESPERA DE REPORTE OFICIAL. DE ACUERDO A LA IMAGEN Y LA CLÍNICA, SE INICIA MANEJO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA-SULBACTAM Y CLARITROMICINA. CONTINÚA CON MANEJO ANTIHIPERTENSIVO CON ENALAPRIL. PENDIENTE REPORTE DE BACILOSCOPIA, Y OTROS PARACLÍNICOS. ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 04/01/2020: 10:24:22, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. NEUMONÍA MULTILOBAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE MEJORÍA, NIEGA DEPOSICIONES LIQUIDAS CON MOCO O SANGRE, NIEGA TOS, NIEGA FIEBRE.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL SEMSECA, CUELLO MÓVIL SIN MASAS ADENOMEGALIAS, MECÁNICA VENTILATORIA SIN ALTERACIONES, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN HEMTORAX DERECHO, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, LOS PULSOS PERIFÉRICOS ESTÁN PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

LA PALPACIÓN, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, LOS PULSOS PERIFÉRICOS ESTÁN PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EDE 71 AÑOS CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS INFECCIOSA, SIN EMBARGO YA SE ENCUENTRA RESUELTA POR SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE PROCESO RESPIRATORIO, SE ORDENÓ TAC DE TÓRAX QUE MUESTRA INFILTRADOS ALVEOLARES MULTILOBULAR IZQUIERDO (LÓBULO SUPERIOR Y LÓBULO INFERIOR), A LA ESPERA DE REPORTE OFICIAL. CON BACILOSCOPIA POSITIVA PARA BAAR (+) POR LO CUAL SE SOLICITA VALORACION POR INFECTOLOGIA. POR SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA SE SUSPENDE ENALAPRIL Y SE INICIA LOSARTAN. SE LE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 04/01/2020: 10:25:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. NEUMONÍA MULTILOBAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE MEJORÍA NIEGA DEPOSICIONES LIQUIDAS CON MOCO O SANGRE, NIEGA TOS, NIEGA FIEBRE.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL SEMSECA, CUELLO MÓVIL SIN MASAS ADENOMEGALIAS, MECÁNICA VENTILATORIA SIN ALTERACIONES, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN HEMTORAX DERECHO, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, LOS PULSOS PERIFÉRICOS ESTÁN PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EDE 71 AÑOS CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS INFECCIOSA, SIN EMBARGO YA SE ENCUENTRA RESUELTA POR SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE PROCESO RESPIRATORIO, SE ORDENÓ TAC DE TÓRAX QUE MUESTRA INFILTRADOS ALVEOLARES MULTILOBULAR IZQUIERDO (LÓBULO SUPERIOR Y LÓBULO INFERIOR), A LA ESPERA DE REPORTE OFICIAL. CON BACILOSCOPIA POSITIVA PARA BAAR (+) POR LO CUAL SE SOLICITA VALORACION POR INFECTOLOGIA. POR SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA SE SUSPENDE ENALAPRIL Y SE INICIA LOSARTAN. SE LE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 04/01/2020: 11:58:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGALIAS, SIN INGURGUTACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR) SE DILIGENCIA FICHA EPIDEMIOLOGICA Y SE ENTREGA A JEFE DE PERSONAL DE ENFERMERÍA; ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, POR LO DESCRITO SE INICIA TERAPIA CON RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ISONIACIDA Y ESTAMBUTOL + PIRIDOXINA, POR EL PESO SE CALCULAN TRES (3) TABLETAS DIARIAS, SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO Y SEGUIMIENTO POR EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 04/01/2020: 11:59:22, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGALIAS, SIN INGURGUTACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR) SE DILIGENCIA FICHA EPIDEMIOLOGICA Y SE ENTREGA A JEFE DE PERSONAL DE ENFERMERÍA; ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, POR LO DESCRITO SE INICIA TERAPIA CON RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ISONIACIDA Y ESTAMBUTOL + PIRIDOXINA, POR EL PESO SE CALCULAN TRES (3) TABLETAS DIARIAS, SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO Y SEGUIMIENTO POR EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/01/2020: 09:32:33, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON DIAGNOSTICOS: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGALIAS, SIN INGURGUTACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EDAD 71 AÑOS CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS INFECCIOSA RESUELTA, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR BACILOSCOPIA SERIADA POSITIVA (BAAR), CON REPORTE DE TAC DE TORAX QUE EVIDENCIA OPACIDAD ALVEOLAR Y RETICULONODULAR EN CAMPO PULMONAR IZQUIERDO HACIA BASE Y LS CON APARIENCIA DE PROCESO INFLAMATORIO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, CON SIGNOS VITALES DENTRO DE LÍMITES NORMALES, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, POR LO QUE SE DA CIERRE A INTERCONSULTA POR PARTE DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, SE INDICA MANEJO PARA PATOLOGÍA DE BASE, CONTINUA SEGUIMIENTO POR SERVICIO DE INFECTOLOGÍA CON INICIO DE TERAPIA CON CON RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ISONIACIDA Y ESTAMBUTOL + PIRIDOXINA, POR EL PESO SE CALCULAN TRES (3) TABLETAS DIARIAS. SE LE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/01/2020: 09:33:17, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON DIAGNOSTICOS: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGALIAS, SIN INGURGUTACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EDAD 71 AÑOS CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE GASTROENTERITIS INFECCIOSA RESUELTA, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR BACILOSCOPIA SERIADA POSITIVA (BAAR), CON REPORTE DE TAC DE TORAX QUE EVIDENCIA OPACIDAD ALVEOLAR Y RETICULONODULAR EN CAMPO PULMONAR IZQUIERDO HACIA BASE Y LS CON APARIENCIA DE PROCESO INFLAMATORIO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, CON SIGNOS VITALES DENTRO DE LÍMITES NORMALES, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, POR LO QUE SE DA CIERRE A INTERCONSULTA POR PARTE DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, SE INDICA MANEJO PARA PATOLOGÍA DE BASE, CONTINUA SEGUIMIENTO POR SERVICIO DE INFECTOLOGÍA CON INICIO DE TERAPIA CON CON RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ISONIACIDA Y ESTAMBUTOL + PIRIDOXINA, POR EL PESO SE CALCULAN TRES (3) TABLETAS DIARIAS. SE LE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/01/2020: 11:29:56, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SÍNTOMA

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SE OBSERVA AGRANDAMIENTO DE GLÁNDULA TIROIDES, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGUTACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR +), PENDIENTE #2 Y 3. FICHA EPIDEMIOLÓGICA DILIGENCIADA ENTREGADA A JEFE DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EL DÍA DE AYER (04-01-20); ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, QUIEN AL EXAMEN FÍSICO SE PALPA HIPERTROFIA DE GLÁNDULA TIROIDES DESCRITA, SIN ESTUDIO PREVIO, POR LO QUE SE SOLICITA ECOGRAFÍA TIROIDEA. TERAPIA RIPE + PIRIDOXINA SOLICITADA SIN INICIO POR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO Y SEGUIMIENTO POR EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, CIERRE POR EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 06/01/2020: 12:02:15, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SÍNTOMA.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SE OBSERVA AGRANDAMIENTO DE GLÁNDULA TIROIDES, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR +), PENDIENTE #2 Y 3. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, QUIEN AL EXAMEN FÍSICO SE PALPA HIPERTROFIA DE GLÁNDULA TIROIDES DESCRITA, SIN ESTUDIO PREVIO, PENDIENTE ECOGRAFIA TIROIDEA SE SOLICITAN PARACLÍNICOS ADICIONALES PARA DETERMINAR ETIOLOGÍA/ESTADÍO DEBIDO A FUNCIÓN RENAL ALTERADA. TERAPIA RIPE + PIRIDOXINA SOLICITADA SIN INICIO POR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO Y SEGUIMIENTO POR EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, CIERRE POR EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 06/01/2020: 12:03:00, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SÍNTOMA.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SE OBSERVA AGRANDAMIENTO DE GLÁNDULA TIROIDES, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR +), PENDIENTE #2 Y 3. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, QUIEN AL EXAMEN FÍSICO SE PALPA HIPERTROFIA DE GLÁNDULA TIROIDES DESCRITA, SIN ESTUDIO PREVIO, PENDIENTE ECOGRAFIA TIROIDEA SE SOLICITAN PARACLÍNICOS ADICIONALES PARA DETERMINAR ETIOLOGÍA/ESTADÍO DEBIDO A FUNCIÓN RENAL ALTERADA. TERAPIA RIPE + PIRIDOXINA SOLICITADA SIN INICIO POR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO Y SEGUIMIENTO POR EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, CIERRE POR EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 07/01/2020: 10:13:25, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SÍNTOMA.

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, SIMÉTRICO, SE OBSERVA AGRANDAMIENTO DE GLÁNDULA TIROIDES, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15 / 15. 06/01/2020 ALBUMINA: 3.0, BUN: 17, CREATININA: 2.28, CL: 110, K: 5.0, MG: 1.8, NA: 141, FOSFORO: 2.9. UROANÁLISIS: LIG TURBIO, DENSIDAD: 1010, PH: 7.0, SEDIMENTO: CEL EPI: 0-2 XC, LEU: 0-2, HEMATIES: 0-2, BACTERIAS: +, MOCO: +. CALCIO IÓNICO: 1.4.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, HOSPITALIZADA POR DIARREA RESUELTA, A QUIEN, POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS POSITIVA (BAAR +), PENDIENTE #2 Y 3. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO 02 AMBIENTE, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, QUIEN AL EXAMEN FÍSICO SE PALPA HIPERTROFIA DE GLÁNDULA TIROIDES DESCRITA, POR LO QUE SE SOLICITA ECOGRAFIA TIROIDEA QUE REPORTA NODULO TIROIDEO CON CARACTERÍSTICAS DE MALIGNIDAD POR LO QUE SE SOLICITA VALORACIÓN POR CIRUGÍA GENERAL. SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL CON MAGNESIO Y CALCIO IÓNICO Y ADEMÁS CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. SE INICIA TERAPIA RIPE EL DÍA DE HOY. ESTA PENDIENTE ECOGRAFIA RENAL Y DE VÍAS URINARIAS, HEMOCULTIVOS Y COPROCULTIVO. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 08/01/2020: 08:28:57, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL, NIEGA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA, NIEGA FIEBRE, DOLOR, U OTRA SÍNTOMA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON MASA PALPABLE EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15

PARACLINICOS: CALCIO 1.51, CLORO 109, POTASIO 4.4, MAGNESIO 1.4, SODIO 140

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, CON 1RA BACILOSCOPIA BAAR POSITIVA, CON HIPERTROFIA TIROIDEA, CON REPORTE DE CARACTERÍSTICAS DE MALIGNIDAD. ACTUALMENTE SIN TERAPIA RIPE EN ESPERA DE DEFINIR CARACTERÍSTICAS Y PLAN DE MANEJO DE ENFERMEDAD TIROIDEA Y ESTADO FUNCIONAL RENAL. EN ESPERA DE VALORACION POR CIRUGIA GENERAL. SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL CON MAGNESIO Y CALCIO IONICO, PENDIENTE CULTIVO PATA MTB, PTH, VITAMINA D, HEMOCULTIVOS, COPROCULTIVOS, BK DE ESPUTO #2 Y 3. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 09/01/2020: 12:00:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON MASA PALPABLE EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, CON 1RA BACILOSCOPIA BAAR POSITIVA, CON HIPERTROFIA TIROIDEA, CON REPORTE DE CARACTERÍSTICAS DE MALIGNIDAD. ACTUALMENTE SIN TERAPIA RIPE EN ESPERA DE DEFINIR CARACTERÍSTICAS Y PLAN DE MANEJO DE ENFERMEDAD TIROIDEA Y ESTADO FUNCIONAL RENAL. RECIBE REPORTE DE IONOGRAMA CON EVIDENCIA DE HIPOMAGNESEMIA LEVE. SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL CON MAGNESIO Y CALCIO IONICO Y PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL. PENDIENTE CULTIVO PARA MTB, PTH, VITAMINA D, HEMOCULTIVOS, COPROCULTIVOS, BK DE ESPUTO #2 Y 3. SE CONTINUA MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 10/01/2020: 09:42:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLINICOS:

BUN: 16, CREATININA 2.64, TFG (CKD-EPI): 18, CLORO 108, POTASIO 4.0, CALCIO 1.45, MAGNESIO 1.5, SODIO 1.38

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, CON HIPERCLOREMIAS LEVES ASINTOMÁTICAS. EL GRUPO DE CIRUGIA CONSIDERA QUE PUEDE SER MANEJADA DE MANERA AMBULATORIA AL MOMENTO QUE EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA CONSIDERE DAR DE ALTA, POR LO CUAL SE DECIDE DAR CIERRE A LA INTERCONSULTA, POR LO QUE SE DECIDE INICIAR TERAPIA RIPE Y SE SOLICITA REALIZACIÓN DE BACAF DE TIROIDES. PENDIENTE RESULTADOS DE NIVELES DE PTH, VITAMINA D, PTH Y CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 11/01/2020: 11:08:48, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, CON REPORTE DE GRUPO DE ENFERMERÍA DE CIFRAS TENSIONALES FUERA DE META, POR LO QUE SE AGREGA ANTIHIPERTENSIVO (AMLODIPINO) A MANEJO, Y SE INICIA TERAPIA RIPE, RESTO DE MANEJO IGUAL. CON HIPERCLOREMIAS LEVE ASINTOMÁTICA, POR LO QUE SE SOLICITA IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL. PENDIENTE REALIZACIÓN DE BACAF DE TIROIDES. PENDIENTE RESULTADOS DE NIVELES DE PTH, VITAMINA D, Y CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 12/01/2020: 12:04:10, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE HIPOREXIA, NIEGA TOS Y EXPECTORACIONES, NIEGA CEFALÉA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, CIFRAS TENSIONALES EN META, SE CONTINUA TERAPIA RIPE, RESTO DE MANEJO IGUAL. CON HIPOMAGNEMIA LEVE, POR LO QUE SE INDICA REPOSICIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL. SE SOLICITA INTERCONSULTA CON NUTRICIÓN POR HIPOREXIA, ESTADO NUTRICIONAL COMPROMETIDO DE LA PACIENTE POR NO CONSUMO DE ALIMENTOS INSTITUCIONALES. PENDIENTE REALIZACIÓN DE BACAF DE TIROIDES. PENDIENTE RESULTADOS DE NIVELES DE PTH, VITAMINA D, Y CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 13/01/2020: 09:16:09, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. HIPOMAGNEMIA LEVE

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE HIPOREXIA, NIEGA TOS Y EXPECTORACIONES, NIEGA CEFALÉA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS:

BUN 12, CREATININA 2.26, CLORO 108, POTASIO 4.4, SODIO 142, MAGNESIO 1.5

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SE CONTINUA TERAPIA RIPE. ANTE PERSISTENCIA DE HIPOMAGNEMIA LEVE, SE CONTINUA REPOSICIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO. SE SOLICITA IONOGRAMA, TIEMPOS DE COAGULACIÓN Y FUNCIÓN RENAL CONTROL. EN ESPERA DE INTERCONSULTA CON NUTRICIÓN POR HIPOREXIA, ESTADO NUTRICIONAL COMPROMETIDO DE LA PACIENTE POR NO CONSUMO DE ALIMENTOS INSTITUCIONALES. PENDIENTE REALIZACIÓN DE BACAF DE TIROIDES. PENDIENTE RESULTADOS DE NIVELES DE PTH, VITAMINA D, Y CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, RESTO DE MANEJO IGUAL. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 14/01/2020: 09:28:32, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. HIPOMAGNEMIA LEVE

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA TOS Y EXPECTORACIONES, NIEGA CEFALÉA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

PARACLINICOS:

06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5

13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SE CONTINUA TERAPIA RIPE. SE CONTINUA CON REPOSICIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL. RESULTADOS DE PTH Y VITAMINA D DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD. SE INSISTE EN INTERCONSULTA CON NUTRICIÓN YA QUE LA PACIENTE REFIERE NO CONSUMIR ALGUNOS ALIMENTOS Y SE ESPERA QUE HAGA ALGUNOS CAMBIOS SE PUEDAN OFRECER A LA PACIENTE INSTITUCIONALMENTE, PUESTO QUE SU ESTANCIA SE PROLONGARA POR ALGUNOS DÍAS Y SE ESPERA PROTEGER DE CREAR ORGANISMOS RESISTENTES ANTE UNA EVENTUAL SALIDA VOLUNTARIA, ASÍ COMO GARANTIZAR UN BUEN APOORTE ALIMENTICIO A LA PACIENTE. PENDIENTE REALIZACIÓN DE BACAF DE TIROIDES, BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 15/01/2020: 07:59:40, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. HIPOMAGNASEMIA LEVE

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGATOS Y EXPECTORACIONES, NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE, SE SUSPENDE REPOSICIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO HASTA TENER CONOCIMIENTO DEL VALOR ACTUAL DE MAGNESIO POR LO QUE SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL. SE INSISTE EN INTERCONSULTA CON NUTRICIÓN YA QUE LA PACIENTE REFIERE NO CONSUMIR ALGUNOS ALIMENTOS Y SE ESPERA QUE HAGA ALGUNOS CAMBIOS SE PUEDAN OFRECER A LA PACIENTE INSTITUCIONALMENTE, PUESTO QUE SU ESTANCIA SE PROLONGARA POR ALGUNOS DÍAS Y SE ESPERA PROTEGER DE CREAR ORGANISMOS RESISTENTES ANTE UNA EVENTUAL SALIDA VOLUNTARIA, ASÍ COMO GARANTIZAR UN BUEN APOORTE ALIMENTICIO A LA PACIENTE. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 16/01/2020: 09:28:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN AUNQUE SE LE DIFICULTAN LAS DEPOSICIONES, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, DIARREA VÓMITOS U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS:

06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5

13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7

15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE, SE SUSPENDE REPOSICIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO HASTA TENER CONOCIMIENTO DEL VALOR ACTUAL DE MAGNESIO POR LO QUE SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, EL DIA DE HOY SE AÑADIO BISACODILO A MANEJO INSTAURADO POR DIFICULTAD PARA LAS DEPOSICIONES REFERIDA POR LA PACIENTE Y SE LE SOLICITARON IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL POR DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO PREVIO, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 17/01/2020: 15:07:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE DEPOSICIONES ADECUADAS, NIEGA FIEBRE, VOMITO U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÚDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, EL DÍA DE HOY SE LE SOLICITARON IONOGRAMA+ MAGNESIO CONTROL POR DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO PREVIO, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 18/01/2020: 12:12:40, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÚDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE DEPOSICIONES ADECUADAS, NIEGA FIEBRE, VOMITO U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÚDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, EL DÍA DE HOY SE LE SOLICITARON IONOGRAMA+ MAGNESIO CONTROL POR DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO PREVIO, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 19/01/2020: 11:05:48, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÚDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÚDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

HIDROELECTROLITICO RESUELTO, SIN EMBARGO SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD . SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 20/01/2020: 12:21:34, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DÍA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO . PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS ,PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLITICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD . SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 21/01/2020: 10:56:40, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 10 DIA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DÍA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO . PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS ,PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLITICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD . SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 22/01/2020: 08:25:27, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 11 DIA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS ,PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLITICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 22/01/2020: 08:26:13, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 11 DIA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS ,PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLITICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 23/01/2020: 10:22:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGION VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137. 22/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.2, MAGNESIO 1.73, SODIO 140.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 12 DIA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA, PULMOCARE LIQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DIA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITO BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS ,PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLITICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MEDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 24/01/2020: 13:10:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO EN MANEJO

Subjetivo:

ACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137. 22/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.2, MAGNESIO 1.73, SODIO 140. 23/01/2020 CL 110, K 4.3, MG 1.6, NA 141.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 13 DÍA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, PULMOCARE LÍQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DÍA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITA BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PACIENTE CON TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO (HIPOMAGNESEMIA LEVE) POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL, SE MANTIENE EL MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD Y SE LE ACTUALIZAN PARACLINICOS PARA EL DÍA DE MAÑANA DEFINIR CONDUCTA SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 25/01/2020: 10:58:57, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO. 5. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO EN MANEJO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137. 22/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.2, MAGNESIO 1.73, SODIO 140. 23/01/2020 CL 110, K 4.3, MG 1.6, NA 141. 24/07/2020 AST 27, ALT 36, BUN 20, CREATININA 2.46, BT 0.2, BD 0.1, BI 0.10, CL 110, K 4.2, MG 1.2, FOSFATASA ALCALINA 101, NA 140.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, EN TERAPIA RIPE HOY SU 14 DÍA. PACIENTE VALORADA POR NUTRICIÓN QUIENES CONSIDERAN QUE REQUIERE ALIMENTO PARA USO ESPECIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, PULMOCARE LÍQUIDO POR 237ML, 3 BOTELLAS AL DÍA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS EN FALENCIA, MAS RÉGIMEN CONVENCIONAL, SIN EMBARGO ESTE NUTRIMENTO NO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO. PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITA BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS, PENDIENTE BK #2 Y #3, Y RESULTADOS DE CULTIVO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PARACLINICOS CONTROL QUE EVIDENCIAN AZOADOS ELEVADOS E HIPOMAGNESEMIA LEVE POR LO QUE SE CONTINUA EN REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA + MAGNESIO CONTROL PARA DEFINIR SALIDA SE MANTIENE EL MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD Y SE LE ACTUALIZAN PARACLINICOS PARA EL DÍA DE MAÑANA DEFINIR CONDUCTA SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 26/01/2020: 08:56:35, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS CON IDX: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA RESUELTA 4. NÓDULO TIROIDEO EN ESTUDIO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN LESIONES. CUELLO: MÓVIL, CON BOCIO GRADO 3 SEGUN OMS EN REGIÓN VI, NO DOLOROSA, NO CALIENTE, DURA, NO MÓVIL, SIN PRESENCIA DE OTRAS MASAS O ADENOPATÍAS, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CREPITOS BASALES EN BASE IZQUIERDA, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS POSITIVA, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. GENITOURINARIO: NO EXPLORA. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS DISTALES ESTÁN PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE DOS SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA EN LAS TRES ESFERAS, SIN DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 06/01/2020: PTH INTACTA 39.5, VITAMINA D 25 - CALCIFEROL 40.5 13/01/2020: BUN 14, CREATININA 2.44, CLORO 107, POTASIO 4.42, SODIO 141.7, MAGNESIO 1.7 15/01/2020 BUN 18, CREATININA 2.46, CLORO 106, POTASIO 4.36, SODIO 137.7, MAGNESIO 3.3, CALCIO 1.36 16/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.74, MAGNESIO 2.8, SODIO 139.7. 17/01/2020 BUN 17, CREAT 2.82, CALCIO 1.42, CLORO 108, POTASIO 4.79, MG 1.9, SODIO 138.3. 19/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.5, SODIO 138 20/01/2020 CLORO 108, POTASIO 4.6, MAGNESIO 1.5, SODIO 139. 21/01/2020 CLORO 106, POTASIO 4.5, MAGNESIO 1.7, SODIO 137. 22/01/2020 CLORO 109, POTASIO 4.2, MAGNESIO 1.73, SODIO 140. 23/01/2020 CL 110, K 4.3, MG 1.6, NA 141. 24/07/2020 AST 27, ALT 36, BUN 20, CREATININA 2.46, BT 0.2, BD 0.1, BI 0.10, CL 110, K 4.2, MG 1.2, FOSFATASA ALCALINA 101, NA 140.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN SIRS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, CON PARACLINICOS DENTRO DE LÍMITES EXCEPTUANDO FUNCIÓN RENAL QUE ESTA ALTERADA, SIGNOS VITALES EN METAS, PACIENTE QUIEN A CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE TIEMPO PROTOCOLARIO DE TERAPIA RIPE INTRAHOSPITALARIO HOY 15 DÍAS CON ADECUADA TOLERANCIA, POR LO QUE EL DÍA DE HOY SE DECIDE DAR ALTA MEDICA CON TERAPIA AMBULATORIA, CITA CONTROL, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO DE CARACTERÍSTICAS MALIGNAS POR LO QUE SE LE SOLICITA BACAF DE TIROIDES DE LO CUAL ESTA PENDIENTE RESULTADOS QUE PUEDEN SER RECLAMADOS DE MANERA EXTERNA PARA POSTERIOR REVALORACION AMBULATORIA, ADEMÁS SE LE DA ALTA CON CITA CON NEFROLOGIA POR LA PERSISTENCIA DE AZOADOS ELEVADOS Y SE LE SOLICITAN BUN, CREATININA PARA LLEVAR A CITA CON NEFROLOGIA. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 02/01/2020

- 871121 - RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)- Cantidad: 1
- 901101 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEESEN]- Cantidad: 1
- 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, ÍNDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903841 - GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA - Cantidad: 1
- 903856 - NITRÓGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 04/01/2020

- 901107 - COLORACIÓN GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA - Cantidad: 1
- 901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIEHL-NEESEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS - Cantidad: 1
- 901206 - COPROCULTIVO - Cantidad: 1
- 901209 - CULTIVO DE LÍQUIDOS CORPORALES (BILIS, LCR, PERITONEAL, PLEURAL, ASCÍTICO, SINOVIAL, OTROS DIFERENTE A ORINA) - HERIDAS: MICROSCÓPICO, CULTIVO Y AB, GERMINES COMUNES - Cantidad: 1
- 901221 - HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA - Cantidad: 1
- 906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS - Cantidad: 1
- 906913 - PROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 907002 - COPROLOGICO - Cantidad: 1

Fecha: 05/01/2020

- 881141 - ECOGRAFÍA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MÁS - Cantidad: 1
- 903603 - CALCIO AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903803 - ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903856 - NITRÓGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903866 - TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
- 903867 - TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 06/01/2020

- 881332 - ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VÉJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)- Cantidad: 1
- 903603 - CALCIO AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903604 - CALCIO IÓNICO - Cantidad: 1
- 903706 - VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [DD3] [CALCIFEROL] - Cantidad: 1
- 903803 - ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903835 - FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903856 - NITRÓGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 904912 - HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA - Cantidad: 1
- 907106 - UROANÁLISIS - Cantidad: 1

Fecha: 07/01/2020

- 901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1
- 903604 - CALCIO IÓNICO - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 08/01/2020

-890331 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO- Cantidad: 1

-903604 - CALCIO IONICO - Cantidad: 2

-903813 - CLORO - Cantidad: 2

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-904902 - HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES - Cantidad: 1

-904921 - TIROXINA LIBRE - Cantidad: 1

-904922 - TIROXINA TOTAL - Cantidad: 1

-904924 - TRIYODOTIRONINA LIBRE - Cantidad: 1

-904925 - TRIYODOTIRONINA TOTAL - Cantidad: 1

-906458 - TIROIDEOS MICROSOALES ANTICUERPOS (TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-906463 - TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

Fecha: 09/01/2020

-903604 - CALCIO IONICO- Cantidad: 1

-903706 - VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [DD3] [CALCIFEROL] - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-904912 - HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA - Cantidad: 1

Fecha: 10/01/2020

-898003 - ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN CITOLOGÍA POR ASPIRACIÓN DE CUALQUIER TEJIDO U ÓRGANO [BACAF]- Cantidad: 1

Fecha: 11/01/2020

-903603 - CALCIO AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 12/01/2020

-903603 - CALCIO AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 13/01/2020

-902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]- Cantidad: 1

-902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] - Cantidad: 1

-903604 - CALCIO IONICO - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 15/01/2020

-903604 - CALCIO IONICO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 16/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 17/01/2020

-903604 - CALCIO IONICO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 19/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 20/01/2020
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 21/01/2020
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 22/01/2020
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 23/01/2020
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 24/01/2020
 -903603 - CALCIO AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903604 - CALCIO IONICO - Cantidad: 1
 -903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
 -903813 - CLORO - Cantidad: 1
 -903833 - FOSFATASA ALCALINA - Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 Fecha: 25/01/2020
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Fecha: 02/01/2020
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 m.l- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 1
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 1
 -0025 - Intracath # 18 - Cantidad: 4
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 2
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 1
 -HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 2
 Fecha: 03/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 5
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 3
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -HUCDES188 - RECOLECTOR DE COPROLOGICO - NUBENCO - ITEM(194) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 2
 Fecha: 04/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 1
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 1
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 5
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -C09AE002012 - Enalapril maleato - Cantidad: 2
 -CLARIT500MG- Claritromicina - Cantidad: 2
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 1
 -J01CA028721 - Ampicilina sódica + Sulbactam sódico - Cantidad: 8
 Fecha: 05/01/2020
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo- Cantidad: 3
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 2
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 2
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 2
 Fecha: 08/01/2020
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo- Cantidad: 2
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 Fecha: 10/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 20
 -0116 - Equipo Bomba de Infusión fresenius - Cantidad: 4

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

-A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 6
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 10
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 10
 Fecha: 11/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 10
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 4
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 1
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 4
 Fecha: 12/01/2020
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo- Cantidad: 1
 Fecha: 14/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 8
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 2
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 2
 -N03AM001701 - SULFATO DE MAGNESIO - Cantidad: 2
 Fecha: 16/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 20
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 5
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 5
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 10
 Fecha: 22/01/2020
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 15
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 3
 -0116 - Equipo Bomba de Infusión fresenius - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 10
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 5
 -A06AB010021 - Bisacodilo - Cantidad: 1
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 5
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 5
 -HUCDES174 - LLAVES TRES VIAS C/EXTENS DE 10 - VYGON - ITEM(177) - Cantidad: 3
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 10
 Fecha: 25/01/2020
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 m.l- Cantidad: 10
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) - Cantidad: 12
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 3
 -0026 - Intracath # 20 - Cantidad: 2
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 20
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 4
 -A06AB010021 - Bisacodilo - Cantidad: 4
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 4
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 36
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES174 - LLAVES TRES VIAS C/EXTENS DE 10 - VYGON - ITEM(177) - Cantidad: 2
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 5
 -LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 8

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 02/01/2020
 Indicaciones:
 OBSERVACION
 SSN 0.9% 500 CC PASAR A 80 CC HORA
 S/S HEMOGRAMA, BUN, CREATININA, BK, IONOGRAMA, GLICEMIA, RX DE TORAX PA Y LATERAL IZQUIERDA
 S/S VALORACION POR MEDICINA INTERNA
 CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 04/01/2020
 Indicaciones:
 - INICIAR TERAPIA RIPE TRES (3) TABLETAS VO UNA VEZ CADA DÍA
 - PIRIDOXINA 50 MG VO CADA DÍA

Fecha: 04/01/2020
 Indicaciones:
 -HOSPITALIZACION
 -DIETA HIPOSODICA
 -HARTMAN PASAR A 70CC/H
 -AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 6 HORAS FI: 03/01/2020
 -CLARITROMCINA 500 MG VO CADA 12 HORAS FI: 03/01/2020
 -ENALAPRIL 20 MG VO CADA 12 HORAS::: SUSPENDER::

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

-LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
 -OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
 -PENDIENTE CROPOLOGICO, COLORACION DE GRAM, HEMOCULTIVO X2, PCR, COPROCULTIVO,
 -CONTROL SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

Fecha: 04/01/2020

Indicaciones:

-HOSPITALIZACION
 -DIETA HIPOSODICA
 -HARTMAN PASAR A 70CC/H
 -AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 6 HORAS FI: 03/01/2020
 -CLARITROMICINA 500 MG VO CADA 12 HORAS FI: 03/01/2020
 -ENALAPRIL 20 MG VO CADA 12 HORAS:: SUSPENDER::
 -LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
 -OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
 -S/S VALORACION POR INFECTOLOGIA
 -CONTROL SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

Fecha: 05/01/2020

Indicaciones:

- SE SOLICITA FUNCIÓN RENAL, IONOGRAMA Y ALBUMINA CONTROL.
 - SE SOLICITA AST, ALT Y BILIRRUBINAS TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA
 - SE SOLICITA ECOGRAFÍA DE TIROIDES.
 - RESTO DE ORDENES POR MEDICINA INTERNA

Fecha: 05/01/2020

Indicaciones:

-HOSPITALIZACION
 -DIETA HIPOSODICA
 -HARTMAN PASAR A 70CC/H
 -LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
 -OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
 -PENDIENTE COPROLOGICO, COLORACION DE GRAM, HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2
 - TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA
 - PIRIDOXIMA 50MG VO DIA
 -SEGUIMIENTO POR INFECTOLOGIA
 - CIERRE DE INTERCONSULTA POR MEDICINA INTERNA
 -CONTROL SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

Fecha: 06/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA HIPOSODICA
 - LACTATO DE RINGER PASAR A 70CC/HORA
 - TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA
 - PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA
 - LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
 - CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - S/S IONOGRAMA COMPLETO, BUN, CREATININA, PTH, FOSFORO, ALBUMINA, VIT D-25-H
 - S/S UROANALISIS, ECOGRAFÍA RENAL Y DE VÍAS URINARIAS
 - P/ HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2

Fecha: 06/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA HIPOSODICA
 - LACTATO DE RINGER PASAR A 70CC/HORA
 - TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA
 - PIRIDOXIMA 50MG VO DIA
 - LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
 - S/S IONOGRAMA COMPLETO, BUN, CREATININA, PTH, FOSFORO, ALBUMINA, VIT D-25-H
 - UROANALISIS, ECOGRAFÍA RENAL Y DE VÍAS URINARIAS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
 - P/ HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2
 - CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 07/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 70CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- S/S IONOGRAMA COMPLETO, MG, CA IONICO, CULTIVO PARA MTB
- SS/ VALORACION POR CIRUGIA GENERAL
- P/ PTH, VIT D-25-H
- P/ ECOGRAFIA RENAL Y DE VIAS URINARIAS
- P/ HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2

Fecha: 08/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 70CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA (NO INICIAR HASTA NUEVA ORDEN)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- S/S IONOGRAMA COMPLETO, MG, CA IONICO
- P/ CULTIVO PARA MTB
- P/ PTH, VIT D-25-H
- P/ HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2
- P/ VALORACION POR CX GENERAL

Fecha: 08/01/2020

Indicaciones:

MANEJO AMBULATORIO CON SERVICIO DE CIRUGIA
 SS/ T4 LIBRE, T4 TOTAL, T3 LIBRE, T3 TOTAL, TSH, ANTICUERPO-ANTIPEROXIDASA, ANTI-TIROGLOBULINA
 CITA CONTROL CON RESULTADOS CON DR HERRERA

Fecha: 09/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 100CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA (NO INICIAR HASTA NUEVA ORDEN)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
- S/S PTH, VIT D-25-H
- S/S IONOGRAMA COMPLETO, MG, CA IONICO, CREATININA, BUN
- P/ CULTIVO PARA MTB
- P/ HEMOCULTIVO X2, COPROCULTIVO, BK X2
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 10/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 100CC/HORA
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO DIA
- S/S BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 11/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VIA ORAL CADA DIA FI: 11/01/20 (D1)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA: NUEVO:
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 11/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D1)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA: NUEVO:
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL
- P/ BK #2 Y #3
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 12/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 100 CC DE SSN 0.9%
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D2)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL
- S/S INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN CLÍNICA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 12/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D2)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL
- P/ BK #2 Y #3
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 13/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 8 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 100 CC DE SSN 0.9%
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D3)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO + CALCIO, FUNCIÓN RENAL CONTROL, TP Y TPT
- P/ INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN CLÍNICA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 14/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 8 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 100 CC DE SSN 0.9%
- INICIAR TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D3)
- PIRIDOXIMA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO
- P/ INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN CLÍNICA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 15/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 8 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 100 CC DE SSN 0.9%:::
- SUSPENDER :::
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D4)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO + CALCIO, BUN, CREATININA
- P/ INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN CLÍNICA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 16/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D5)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN CLÍNICA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 17/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D6)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO, BUN, CREATININA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Fecha: 18/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D7)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 19/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 80 CC/HORA
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D8)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 20/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 60 CC/HORA ::MODIFICADO::
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS ::NUEVO::
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D9)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 21/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 60 CC/HORA
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D10)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 22/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

- LACTATO DE RINGER PASAR A 60 CC/HORA
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D11)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 23/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- LACTATO DE RINGER PASAR A 60 CC/HORA
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D12)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 23/01/2020

Indicaciones:

SOLUCION SALINA PASAR A RAZON DE 60CC/HORA

Fecha: 24/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- SSN 0.9% 500 CC PASAR A 60 CC/HORA
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D13)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO, CALCIO, AST, ALT, FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA
- P/ BK #2 Y #3
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 25/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA HIPOSODICA
- SSN 0.9% 500 CC PASAR A 60 CC/HORA :::SUSPENDER:::
- TAPON VENOSO
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D14)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA
- BISACODILO 5MG VO C / NOCHE
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO.
- P/ REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- CONTROL SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

VER REGISTRO MEDICO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:16:34 p. m.

Admisión: AD568224

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ESTELA MARIA MUÑOZ DE VASQUEZ

EPICRISIS

Complicaciones:

NINGUNA

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 26/01/2020 08:57

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A159 : TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICAMENTE E HISTOLOGICAMENTE

Diagnóstico Relacionado 1: I10X : HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR**MEDICINA:**Tratamiento Farmacológico:

- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VÍA ORAL CADA DÍA FI: 11/01/20 (D15)
- PIRIDOXINA 100 MG VO DÍA
- LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS
- AMLODIPINO 5 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO DÍA

Recomendaciones Adicionales:

- ALTA MEDICA
- S/S BUN, CREATININA
- RECLAMAR EN PATOLOGÍA REPORTE DE BACAF DE TIROIDES
- CITA PRIORITARIA CON NEFROLOGÍA CON RESULTADOS DE BUN, CREATININA
- CITA EN 1 MES CON INFECTOLOGÍA
- VINCULARSE A PROGRAMA PARA PACIENTES CON TBC

Aplica Cuidados de Enfermería: No

SAID CLARETE DE LA ROSA
MEDICINA INTERNA

CC.1128051566 - RM.1128051566